

TRATAMIENTO DEL DOLOR NEUROPÁTICO EN URGENCIAS

Alicia Alonso Cardaño

INTRODUCCIÓN

Cualquier proceso que lesione tejidos nerviosos o cause disfunción neuronal puede producir dolor neuropático (DN). La etiología es muy variada y la fisiopatología compleja.

El DN es una colección de situaciones clínicas que se manifiestan con síntomas o signos positivos y negativos de dolor producido por la lesión del tejido neural. Implican distintos mecanismos de disfunción del sistema somatosensorial, lo que se traduce en una alteración de la forma en que el cerebro procesa los estímulos sensitivos, pérdida de las vías inhibitorias descendentes, aumento de las vías facilitadoras nociceptivas, disfunción de los mecanismos de producción y liberación del GABA, disminución de los receptores opioides M en los ganglios de la raíz dorsal. Se produce: inflamación, activación de las células gliales, cambios en la plasticidad neuronal de las vías nociceptivas transmisoras del dolor.

En resumen, se altera la “maquinaria” que procesa la información dolorosa y se pierde la congruencia estímulo-respuesta, provocando la persistencia del dolor.

Clasificación

- **DN periférico:** estenosis de canal, neuropatía diabética, neuralgia postherpética, masa de tejidos cercanos, radiculopatías, plexopatías, neuralgia del trigémino, etc.
- **DN central:** lesiones medulares, enfermedades desmielinizantes, enfermedad de Parkinson, accidente cerebrovascular, etc.
- **Simpático:** síndrome de dolor regional complejo.

La radiculopatía lumbar es el síndrome de dolor neuropático más frecuente y afecta al 20-35% de todos los pacientes con lumbalgia. Por lo tanto, excluir la posibilidad de un componente de dolor neuropático en el dolor lumbar es el primer escalón en la práctica clínica. Se caracteriza de forma típica por una distribución del dolor que concuerda neuroanatómicamente con la zona de lesión. Las causas más frecuentes de reagudización de una lumbalgia crónica que asocia un componente neuropático es la radiculitis o inflamación de una o más raíces nerviosas, lo que se manifiesta como dolor irradiado a lo largo del dermatoma correspondiente. La mayoría de radiculopatías se deben a la compresión de la raíz del nervio por espondilosis, hernia discal o estenosis de canal espinal, pero también por infección (herpes zoster, VIH, enfermedad de Lyme), compresión por tejido granulomatoso o por tumor, radiación.

Sin embargo, cuando la disfunción sensitiva ha desarrollado un fenómeno de sensibilización central, se produce un aumento de la sintomatología en segmentos no relacionados con la fuente original de dolor, y se distribuye de manera no segmentaria por diversas áreas del organismo. Un estímulo prolongado provoca sensibilización de los receptores a nivel periférico y altera las propiedades de las neuronas espinales, induciendo un aumento de excitabilidad neuronal, con disminución del umbral de excitación y un aumento del tamaño del campo receptor.

DIAGNÓSTICO

Es fundamentalmente clínico

- **Signos positivos**
 - Parestesias: sensación extraña dolorosa (quemazón, alfileres)

- Disestesias: sensación extraña no dolorosa (hormigueo)
- Hiperalgnesia: percepción exacerbada del dolor
- Alodinia: dolor evocado por un estímulo que normalmente no es doloroso
- **Signos negativos:**
 - Hipoalgnesia
 - Hipoestesia
 - Anestesia

Anamnesis

Debe incluir una historia del dolor (cuándo comenzó, evolución, características del dolor actual y distribución, cualidad, intensidad, duración, factores desencadenantes y de alivio, otros síntomas acompañantes, factores psicosociales, hábitos tóxicos, consumo de fármacos y respuesta a los mismos). Existen escalas muy útiles: LANSS, DN-4 y SCREENING TOOL.

Exploración física

Debe comprender una exploración neurológica completa, siendo primordial explorar el sistema somatosensorial (tacto, presión, temperatura, dolor y sensibilidad vibratoria).

Pruebas complementarias

Sobre todo técnicas de imagen. Son útiles para el diagnóstico etiológico y diferencial, pero nunca retrasarán el inicio del tratamiento, que debe ser precoz.

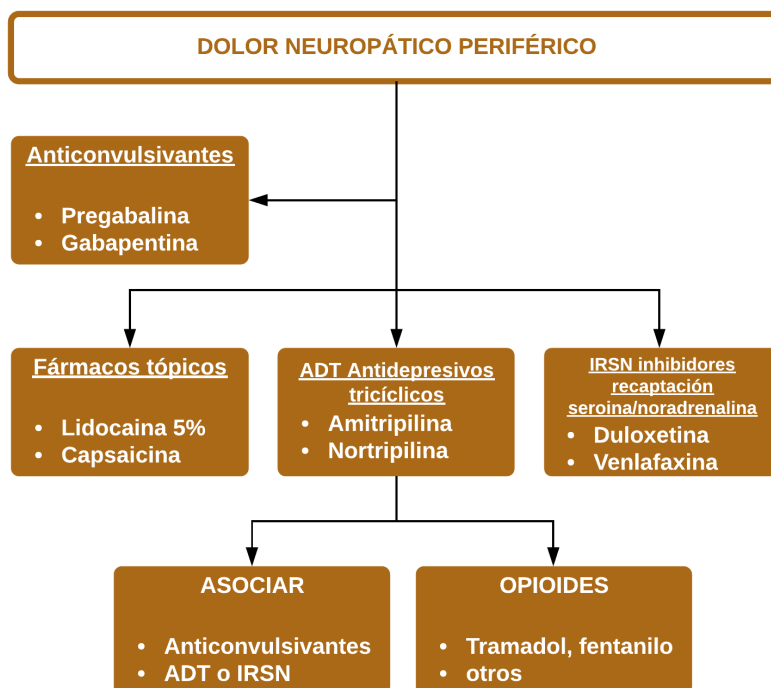
TRATAMIENTO EN URGENCIAS

Precocidad En El Diagnóstico.

Instauración de tratamiento según síntomas, elección de fármaco según mecanismo fisiopatológico y tolerancia del paciente.

Tener en cuenta la posibilidad de coexistencia de dolor nociceptivo junto con el neuropático, y realizar tratamiento específico del mismo.

El dolor neuropático, a diferencia del nociceptivo, no responde a los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) y responde poco a los opioides, por lo que deben valorarse otros fármacos como los antidepresivos y los antiepilépticos.



Arsenal de fármacos para el dolor neuropático.



Propuesta de Algoritmo para el tratamiento del dolor neuropático.

PUNTO/ALERTA

- Buscar siempre los síntomas-guía: alodinia e hiperalgesia.
- El DN no responde a AINES y escasamente a opioides.
- Iniciar tratamiento con amitriptilina, duloxetina, gabapentina o pregabalina.
- Tratar el componente nociceptivo si lo hubiera.

BIBLIOGRAFÍA

- Christopher T. Doughty, Reza Sadjadi, Approach to Peripheral Neuropathy for the Primary Care Clinician, The American Journal of Medicine (2018), <https://doi.org/10.1016/j.amjmed.2017.12.042>.
- Diagnóstico y tratamiento del dolor neuropático. Martínez-Salio M, Gómez A, Ribera MV, Montero J, Blanco E et al. Med Clin 2009; 133 (16): 629 – 636.
- Morlion B. Pharmacotherapy of low back pain: targeting nociceptive and neuropathic pain components. Current Medical Research & Opinion 2011; 27 (1): 11–33.
- Obata H. Analgesic mechanisms of antidepressants for neuropathic pain. Int J Mol Sci 2017; 18:2483.
- Manual de Medicina del Dolor. J. Vidal. Sociedad Española del Dolor 2016. Ed. Panamericana. ISBN: 978-84-9110-095-9.
- Galvez R, Ruiz S, Romero J. Propuesta de nueva escalera analgésica para dolor neuropático. Rev Soc Esp Dolor, 2006; 13(6).